

# PREPARE MON CONCOURS

Résumé 02

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES HÔPITAUX



06 16 03 08 31



slit-anass

**ANASS SLIT- INFIRMIER POLYVALENT**

# **Arrêté de la ministre de la sante n ° 456-11 du 23 Rejeb 1431 (6 juillet 2010) portant règlement intérieur des hôpitaux**

## **I. Organisation administrative hospitalière :**

Conformément aux dispositions du décret susvisé n ° 2-06-656, chaque centre hospitalier régional, préfectoral ou provincial ou hôpital est **dirigé** par un **directeur** nommé par le **ministre** de la sante.

Le **directeur** consacre l'intégralité du temps de travail à la gestion et à l'administration du centre hospitalier ou de L'hôpital selon le cas.

Il ne peut être dérogé à cette règle que sur décision du Ministre de la Sante prise sur proposition du Directeur Régional et du Délégué, et dans le seul cas de nécessité de service, notamment pour combler un manque en personnel médical au centre hospitalier ou à l'hôpital.

### **Attributions du directeur :**

Le directeur du centre hospitalier ou de l'hôpital **assure** :

- ❖ La gestion technique de l'établissement
- ❖ La gestion administrative de l'établissement
- ❖ La gestion financière de l'établissement

Il est responsable de la conduite générale de l'établissement dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et du présent règlement intérieur

Il est responsable de la mise en œuvre de la politique sanitaire, et des directives ministérielles en matière de planification et de gestion hospitalière et veille au bon fonctionnement de l'établissement

Il est notamment chargé de :

- ❖ Veiller à la planification des actions de l'établissement dans le cadre du « **Projet d'établissement hospitalier PEH** »
- ❖ Veiller au respect et à l'application des plans d'actions et des normes et procédures de gestion hospitalière

- ❖ Coordonner les plans d'actions des différents départements et services hospitaliers pour atteindre les objectifs stratégiques de l'établissement
- ❖ Assurer la coordination des activités de l'ensemble des pôles, des départements, des services médicaux ou médico-techniques et s'assurer de la cohérence de leurs activités avec les missions et les objectifs de l'établissement et les ressources disponibles
- ❖ S'assurer que les unités de soins et services évaluent, de façon systématique et continue, la qualité des actes professionnels
- ❖ Veiller à l'exécution des recommandations du « **comité d'établissement** » de l'hôpital
- ❖ Approuver les listes de garde et d'astreinte
- ❖ Elaborer une stratégie de communication interne et externe et soutenir les différents services de l'établissement dans l'élaboration de leurs plans de communication spécifiques
- ❖ Représenter l'établissement vis-A-vis des partenaires, des usagers et des tiers en concertation avec le délégué
- ❖ Coordonner les relations de l'établissement avec les autres composantes de la filière de soins en concertation avec le délégué
- ❖ Informer la hiérarchie de tout incident important ou grave qui survient à l'intérieur de l'établissement
- ❖ Etablir un rapport annuel des activités **techniques, administratives et financières** de l'établissement
- ❖ Gérer les relations de travail avec les différentes instances syndicales locales
- ❖ Mettre à jour annuellement les inventaires de l'hôpital
- ❖ Elaborer le projet de budget annuel et les projets de budgets programmes et veiller et leur exécution

Les directeurs des centres hospitaliers assurent en outre le **secrétariat du comité de gestion**

Le directeur du centre hospitalier régional, préfectoral, provincial ou de l'hôpital a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur et des règles déontologiques et professionnelles.

## **II. Attributions et organisation des pôles de gestion**

Chaque hôpital le composant est organisée en **trois pôles** de gestion :

1. Un pôle des affaires médicales (PAM)
2. Un pôle des soins infirmiers (PSI)
3. Un pôle des affaires administratives (PAA)

### **Le pôle des affaires médicales :**

#### **Missions du pôle :**

Le pôle des affaires médicales est placé **sous la responsabilité l'un médecin.**

- ❖ La coordination et la planification des activités et programmes de soins et de services médicaux, y compris ceux relatifs à l'éducation sanitaire
- ❖ L'évaluation de la qualité et de la performance des soins hospitaliers
- ❖ La formation continue du personnel médical
- ❖ La contribution à la formation continue du personnel paramédical
- ❖ La contribution à la prévention des infections et à l'hygiène de l'établissement
- ❖ La planification et la gestion des ressources destinées au personnel médical

Le pôle des affaires médicales est **organisé en deux ou plusieurs bureaux** en fonction du volume des activités

#### **Attributions du chef du pôle des affaires médicales :**

Sous **l'autorité du directeur** le chef du pôle des affaires médicales assure la gestion du pôle et coordonne l'activité **professionnelle** et **scientifique** de l'établissement. Il est en outre chargé de :

- ❖ Mettre en place des mécanismes favorisant la promotion des bonnes pratiques de soins et leur application
- ❖ Veiller sur la cohérence de l'ensemble des activités cliniques
- ❖ Établir les besoins en médicaments et dispositifs médicaux nécessaires pour les activités hospitalières des départements ou services médicaux et des unités de soins et de services

- ❖ Valider les listes de garde et d'astreinte des médecins et des étudiants en médecine, élaborées par les chefs des départements ou des services médicaux et des unités de soins et de services
- ❖ Élaborer le programme de formation continue des médecins et des médecins dentistes
- ❖ Mettre en œuvre les recommandations du conseil des médecins, médecins dentistes et pharmaciens, après leur approbation par le directeur
- ❖ Veiller à la bonne tenue des dossiers d'hospitalisation
- ❖ Contribuer à l'élaboration du projet d'établissement hospitalier

## **Le pôle des soins infirmiers :**

### **Missions du pôle :**

Le pôle des soins infirmiers est placé **sous la responsabilité d'un cadre titulaire du diplôme d'état d'infirmier**. Il a pour mission de veiller à la bonne gestion des unités de soins et de services paramédicaux. A cet effet, il est notamment chargé des activités suivantes :

- ❖ La coordination et la planification des activités et programmes de soins et de services paramédicaux
- ❖ L'évaluation de leur qualité et performance
- ❖ La contribution à la prévention des infections nosocomiales
- ❖ La planification et la gestion des ressources destinées au personnel paramédical
- ❖ La contribution à l'élaboration et au suivi des programmes d'éducation sanitaire
- ❖ La contribution au développement de la recherche en soins infirmiers
- ❖ Le pôle des soins infirmiers est structuré en deux ou plusieurs bureaux en fonction du volume des activités

### **Attributions du chef du pôle des soins infirmiers :**

- ❖ Sous l'autorité du **directeur**, le chef du pôle des soins infirmiers assure la gestion du pôle et coordonne **l'activité professionnelle** des infirmiers et du personnel **infirmiers** en général. Il est en outre, chargé de :
- ❖ Veiller sur la cohérence des activités paramédicales avec l'ensemble des activités cliniques
- ❖ Valider les listes de garde et d'astreinte des infirmiers élaborées par les chefs de département et unités de soins et de services

- ❖ Élaborer le programme de formation continue des infirmiers en concertation avec le pôle des affaires médicales, et participer à l'encadrement des infirmiers stagiaires :
- ❖ Mettre en œuvre les recommandations du conseil des infirmiers et infirmières, après leur approbation par le directeur.

## **Le pôle des affaires administratives :**

### **Missions du pôle :**

- ❖ Le pôle des affaires administratives est placé **sous la responsabilité d'un cadre administratif**, il a pour mission d'assurer la gestion des ressources humaines et financières ainsi que la gestion des services techniques et de maintenance. Il apporte son appui à l'ensemble des différents services de l'établissement. Le pôle des affaires administratives est chargé des activités suivantes :
- ❖ **En matière de gestion des ressources humaines :**
  - ✓ Assurer la gestion administrative du personnel
  - ✓ Élaborer le plan de développement des ressources humaines
  - ✓ Élaborer des stratégies de mobilisation et de motivation du personnel
  - ✓ Veiller à la bonne application du système d'appréciation du rendement du personnel
  - ✓ Élaborer le plan d'action de la formation continue du personnel du pôle
- ❖ **En matière de gestion administrative, des ressources financières :**
  - ✓ Assurer la gestion budgétaire, financière et comptable
  - ✓ Assurer l'approvisionnement en médicaments, fongibles, matériel et autres produits nécessaires au fonctionnement de l'établissement et en assurer leur distribution
  - ✓ Veiller au recouvrement des créances de l'établissement conformément à la législation et à la réglementation en vigueur
  - ✓ Organiser et gérer les archives administratives de l'établissement.
- ❖ **En matière de gestion des services techniques et de soutien :**
  - ✓ Assurer l'alimentation des patients et du personnel de garde
  - ✓ Assurer le nettoyage et la sécurité des bâtiments et le bandage des linges
  - ✓ Gérer le système interne de télécommunication
  - ✓ Assurer la gestion des déchets hospitaliers

- ✓ Elaborer et mettre en œuvre un plan de gestion et de maintenance des équipements médicaux, des installations techniques, des bâtiments et mobiliers ainsi que du parc automobile

Le pôle des affaires administratives est **organisé en bureaux ou unités** en fonction du volume de ses activités

### **Attributions du chef du pôle des affaires administratives :**

Sous l'autorité du **directeur**, le chef du pôle des affaires administratives assure la gestion de son pôle. Il est en outre chargé :

- ❖ D'assurer le suivi et l'évaluation des activités du pôle - de veiller à la cohérence desdites activités avec la mission de l'établissement
- ❖ De mettre en œuvre les recommandations des instances de concertation et d'appui, qui sont en rapport avec les activités de son pôle, lorsqu'elles sont approuvées par le directeur

## **III. Les instances de concertation et d'appui**

### **6 instances de concertation et d'appui :**

1. Le comité d'établissement
2. Le comité de suivi et d'évaluation
3. Le conseil des médecins, des dentistes et des pharmaciens (CMDP)
4. Le conseil des infirmiers et infirmières (CII)
5. Le comité de lutte contre les infections nosocomiales (CLIN)
6. Le comité de gestion du centre hospitalier

### **1/ Le comité d'établissement :**

#### **Composition du Comité d'établissement :**

Le comité d'établissement est **présidé par le directeur**. Il est composé :

- ❖ Chef du pôle des affaires médicales
- ❖ Chef du pôle des soins infirmiers
- ❖ Chef du pôle des affaires administratives

- ❖ Responsable de la pharmacie
- ❖ Responsable du service d'accueil et d'admission
- ❖ Président du conseil des médecins, des dentistes et des pharmaciens
- ❖ Président du conseil des infirmiers et infirmières
- ❖ Représentant du délégué du ministère de la santé à la préfecture ou province chef-lieu de l'hôpital

Le comité d'établissement peut s'adjoindre, à titre consultatif toute personne dont la présence lui paraît utile en fonction du sujet traité

### **Attributions du comité d'établissement :**

Le comité d'établissement a pour **mission de définir les orientations stratégiques de l'hôpital**

Il est à ce titre, chargé de se prononcer sur :

- ❖ Le Projet d'Etablissement Hospitalier et le plan d'action annuel
- ❖ Le projet de budget de l'hôpital et les projets des contrats programmes
- ❖ Les programmes d'investissement relatifs aux travaux et équipements, établis conformément au projet d'établissement hospitalier (PEH)
- ❖ Les plans de formation continue des différentes catégories du personnel
- ❖ L'allocation des ressources aux services de l'établissement et le développement de mécanismes de synergie entre ces services
- ❖ Les actions de coopération hospitalière intrarégionale et interrégionale
- ❖ Les rapports et recommandations du **Comité de Suivi et d'Evaluation**
- ❖ Le rapport d'activités et l'analyse de la performance et de la qualité des prestations rendues, eu égard aux objectifs préalablement fixés

Il est consulté sur les projets de création, de scission ou de regroupement des départements, services ou unités de soins en fonction des besoins des usagers et des capacités de l'hôpital

Le comité d'établissement se réunit à l'initiative de son président **une fois par trimestre** et autant de fois que les besoins l'exigent



## **2/ Le comité de suivi et d'évaluation**

### **Composition du Comité de suivi et d'évaluation**

Le comité est **présidé par le directeur**, est composé de :

- ❖ Représentant du pôle des affaires médicales
- ❖ Représentant du pôle des soins infirmiers
- ❖ Représentant du pôle des affaires administratives
- ❖ Responsable du service d'accueil et admission
- ❖ Responsable de la pharmacie hospitalière

Le comité peut s'adjoindre à ses réunions toute personne dont il juge la présence utile pour le bon déroulement de ses travaux

Il se réunit **une fois par trimestre**

Le secrétariat est assuré par le responsable du service d'accueil et d'admission

### **Attributions du comité de suivi et d'évaluation :**

Le comité de suivi et d'évaluation a pour mission d'assurer sur la base des orientations du comité d'établissement

- ❖ Le suivi des activités de l'hôpital au niveau clinique et informationnel et le suivi de la gestion des ressources humaines, matérielles et financières
- ❖ L'examen des données sur l'activité hospitalière
- ❖ L'analyse de la performance de l'hôpital et de la qualité des soins.

Le comité de suivi et d'évaluation procède à l'analyse mensuelle des indicateurs et résultats obtenus.

Il identifie et propose, au directeur de l'hôpital, des axes d'amélioration de la qualité et/ou de la performance qui serviront comme éléments indicatifs de la planification stratégique de l'hôpital

### **3/ Le conseil des médecins, des dentistes et des pharmaciens (CMDP) :**

#### **Composition du conseil des médecins des dentistes et des pharmaciens :**

- ❖ Ce conseil est composé des représentants élus des médecins des médecins dentistes et des pharmaciens en fonction à l'hôpital à raison de deux représentants par département ou service clinique ou médico-technique, et deux représentants des autres services cliniques et médico-techniques ne relevant pas des départements
- ❖ Le directeur l'hôpital et le chef du pôle des affaires médicales font partie d'office dudit comité
- ❖ Les membres du conseil des médecins, des dentistes et des pharmaciens élisent parmi eux un président sur la base de sa notoriété clinique

#### **Attributions du conseil des médecins, des dentistes et des pharmaciens :**

Le conseil des médecins, des dentistes et des pharmaciens est chargé :

- ❖ Contribuer à l'élaboration du projet d'établissement - de proposer au comité d'établissement des actions de nature à améliorer la prise en charge des malades
- ❖ Émettre son avis sur toutes les questions d'ordre clinique ou médico-technique intéressant les activités de l'hôpital qui lui sont soumises par le directeur de l'établissement
- ❖ Proposer au directeur des plans de formation continue et de recherche ainsi que toute mesure visant le développement des compétences des médecins, médecins dentistes et pharmaciens de l'hôpital et l'encadrement des étudiants en médecine faisant fonction d'internes
- ❖ Définir les besoins en médicaments, produits pharmaceutiques non médicamenteux et dispositifs médicaux
- ❖ Proposer le plan d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins à l'hôpital

Le conseil se réunit **une fois par trimestre** et autant de fois que les nécessités l'exigent

#### **4/ Le conseil des infirmiers et infirmières (CII) :**

##### **Composition du conseil des infirmiers et infirmières (CII) :**

Le conseil des infirmiers et infirmières est composé :

- ❖ Moitié du responsable du pôle des soins infirmiers, des infirmier(e)s chefs aux départements et des infirmier(e)s chefs aux services
- ❖ Moitié de représentants élus du personnel infirmier des techniciens et des assistants médicaux, lorsqu'ils existent
- ❖ Les membres du conseil élisent, parmi eux, un président sur la base de sa notoriété professionnelle

##### **Attributions du Conseil des infirmiers et infirmières :**

Le conseil est chargé de :

- ❖ Apprécier la qualité et la pertinence des soins infirmiers
- ❖ Contribuer à la formation continue
- ❖ Donner son avis sur les questions relatives à la prestation de soins infirmiers par l'hôpital, qui lui sont soumises par le directeur de l'établissement

Le conseil se réunit **une fois par trimestre** et autant de fois que les besoins l'exigent

Son secrétariat est assuré par le chef du pôle des soins infirmiers.

#### **5/ Le comité de lutte contre les infections nosocomiales (CLIN)**

##### **Composition du comité de lutte contre les infections nosocomiales (CLIN) :**

Le comité de lutte contre les infections nosocomiales comprend outre le **directeur** et les **chefs** de pôles, les membres suivants :

- ❖ Le président du conseil des médecins, médecins dentistes et pharmaciens
- ❖ Les responsables des structures médico-techniques suivantes :
  - ✓ Le laboratoire
  - ✓ La pharmacie hospitalière
- ❖ Un médecin de chacune des spécialités disponibles à l'hôpital

- ❖ L'épidémiologiste en fonction à l'hôpital, lorsqu'il existe
- ❖ Un ingénieur biomédical
- ❖ Le représentant de l'équipe opérationnelle de l'hygiène

Le président du comité est désigné par et parmi les membres du comité

Le comité peut faire appel à toute personne dont il juge la participation utile à ses travaux

### **Attributions du comité de lutte contre les infections nosocomiales (CLIN) :**

Le comité de lutte contre les infections nosocomiales a pour missions de :

- ❖ Proposer le programme d'actions de lutte contre les infections nosocomiales
- ❖ Proposer des mécanismes de coordination des actions menées dans les services hospitaliers en matière de lutte contre les infections nosocomiales ;
- ❖ Participer à la formation des professionnels de santé en matière d'hygiène hospitalière et de lutte contre les infections nosocomiales
- ❖ Proposer un dispositif de surveillance des infections nosocomiales
- ❖ Promouvoir l'application des recommandations de bonnes pratiques en matière d'hygiène hospitalière
- ❖ Évaluer périodiquement les actions de lutte contre les infections nosocomiales ;
- ❖ Organiser des campagnes de sensibilisation et d'information au profit des usagers de l'hôpital

Il est chargé d'établir un rapport périodique de situation sur la lutte contre les infections nosocomiales et de veiller à sa diffusion

Il est consulté par la direction de l'hôpital sur toute question se rapportant à l'hygiène hospitalière, aux infections nosocomiales et à la sécurité du patient

Le comité se réunit à l'initiative de son président au moins **une fois par trimestre** et chaque fois que de besoin

Son secrétariat est assuré par le chef du pôle des affaires médicales

## 6/ Le comité de gestion du centre hospitalier :

### Composition du comité du centre hospitalier :

Il est créé dans chaque centre hospitalier régional, préfectoral ou provincial un comité de gestion, présidé par le délégué du ministère de la santé à la préfecture ou province chef-lieu du centre hospitalier

Le comité comprend, outre son président, les membres suivants :

- ❖ Le directeur du centre hospitalier
- ❖ Les directeurs des hôpitaux composants le centre hospitalier
- ❖ Les chefs des 3 pôles de gestion d'hôpital
- ❖ Le médecin chef du service du réseau d'infrastructure et d'actions ambulatoires provincial ou préfectoral (SIAAP)
- ❖ Les présidents du Conseil des médecins, médecins dentistes et pharmaciens et du conseil des infirmiers et infirmières des hôpitaux composant le centre hospitalier.

Lorsque le centre hospitalier est régional, **le comité de gestion est présidé par le délégué** du ministère de la santé à la préfecture ou province chef-lieu de la région, et comprend outre les membres

- ❖ Les délégués du ministère aux préfectures et provinces de la région
- ❖ Les médecins chefs des services du réseau d'infrastructures et d'actions ambulatoires provincial ou préfectoral (SIAAP) des dites préfectures et provinces
- ❖ Les directeurs des centres hospitaliers préfectoraux e provinciaux de la région
- ❖ Les chefs des pôles de gestion de chaque hôpital composant ces centres hospitaliers et le centre hospitalier régional

Le président du comité de gestion peut faire appel, à titre consultatif, à toute autre personne dont il juge la présence utile

## Attributions e du comité de gestion :

Le comité de gestion est investi d'une mission générale de concertation.de coordination et de suivi des activités du centre hospitalier dans le respect de la réglementation en vigueur. A ce titre, il est chargé de :

- ❖ Veiller à la mise en œuvre des orientations de la politique nationale en matière d'hospitalisation et à la cohérence des actions du centre hospitalier :
- ❖ Analyser le rapport d'activité et évaluer la performance du centre
- ❖ Examiner et approuver le plan d'action annuel du centre hospitalier
- ❖ Donner un avis sur l'allocation des ressources entre les hôpitaux composants le centre ;
- ❖ Donner un avis sur le projet d'établissement du centre hospitalier
- ❖ Définir les actions de coopération interhospitalière et avec es établissements de soins de santé de base

Le comité se réunit **chaque fois que les besoins** du centre hospitalier l'exigent et **au moins deux fois par an**

- ✓ Avant le **15 février** pour analyser le bilan d'activité du centre hospitalier de l'exercice écoulé et examiner le plan d'action de l'année en cours
- ✓ Avant le **15 juillet** pour analyser l'état d'avancement de la mise en œuvre du plan d'action et apporter les ajustements nécessaires

Le comité de gestion délibère valablement lorsqu'au moins la moitié de ses membres sont présents et prend ses décisions à la majorité des voix

Le secrétariat du comité de gestion est assuré par le directeur du centre hospitalier, qui prépare les réunions et élabore les comptes-rendus des dites réunions, dont un exemplaire doit être adressé à chacun des membres

## **IV. Organisation des soins et services**

Les activités médicales, pharmaceutiques ou odontologiques sont organisées au sein d'unités de soins et de services formant soit des départements, soit des services médicaux

### **Organisation des prestations de soins et de services :**

#### **Organisation :**

- **Département et le service médical**

Le département ou le service médical réunit les unités de soins et de services d'une même spécialité ou de spécialités différentes qui partagent le même plateau technique, ou qui s'adressent à la même population cible, ou qui nécessitent une organisation commune

Un service médical peut être :

- ✓ Médical
- ✓ Chirurgical
- ✓ Médico technique

Les unités de soins et de services sont créées sur proposition du comité d'établissement en fonction des prestations à offrir aux patients hospitalisés et de l'organisation optimale des soins

- **Organisation médicale des hôpitaux généraux de moins de 120 lits**

Les hôpitaux généraux de moins de 120 lits sont organisés en **8 services** :

1. Le service d'accueil et d'admission (SAA)
2. Le service des urgences
3. Le service mère-enfant (SME)
4. Le service de médecine (SM)
5. Le service de chirurgie (SC), y compris le bloc opératoire
6. Le service d'imagerie médicale
7. Le service de biologie médicale
8. Le service de la pharmacie hospitalière

## • Organisation médicale des hôpitaux généraux de 120 à 240 lits

Les hôpitaux généraux de 120 à 240 lits sont organisés en **6** départements cliniques et **3** services :

1. Le service d'accueil et d'admission (SAA)
2. Le service des urgences (SU)
3. Le département mère-enfant (DME)
4. Le département de médecine (DM)
5. Le département de chirurgie (DC)
6. Le département de traumatologie-orthopédie et de neurochirurgie lorsqu'elle existe
7. Le département Ophtalmo - ORL - Stomato
8. Le département médico-technique (DMT) regroupant notamment les unités médico techniques suivantes :
  - ✓ L'imagerie médicale
  - ✓ La biologie médicale
  - ✓ L'exploration fonctionnelle
9. Le service de la pharmacie hospitalière (SPH)

## • Organisation médicale des hôpitaux de plus de 240 lits

Les hôpitaux de plus de 240 lits ne peuvent dépasser **8** départements cliniques :

Les urgences doivent être intégrées dans un département clinique dans le respect de la cohérence des activités médicales et chirurgicales. Ils doivent en outre comprendre :

- ❖ Le service de l'accueil et d'admission
- ❖ La pharmacie hospitalière

Toutes les spécialités offertes à l'hôpital doivent être **intégrées** dans les départements correspondants par **décision du directeur** de l'hôpital après avis du **comité d'établissement**

Le bloc opératoire est **rattaché** à l'un des départements de **chirurgie** désigné par le directeur de l'hôpital après avis du **comité d'établissement**



## **Attributions des responsables des départements et des services médicaux et des unités de soins et de services :**

### **• Attributions du chef de département :**

Chaque département est placé sous l'autorité d'un médecin chef assisté par un infirmier chef

Le chef de département est chargé d'organiser le fonctionnement de la structure dont il est responsable, dans le respect de la responsabilité médicale de chaque praticien. Il est notamment chargé :

- ❖ Planifier et gérer les ressources du département ou du service et coordonner les activités professionnelles des médecins dans son département
- ❖ Coordonner l'élaboration multidisciplinaire de la programmation des activités :
- ❖ Assurer de la présence des ressources médicales dans le département et établir les listes du personnel chargé de la garde ou de l'astreinte
- ❖ Veiller au respect des règles d'éthique, de déontologie et de l'application des règles professionnelles
- ❖ Assurer l'encadrement des étudiants et stagiaires des facultés de médecine et de pharmacie

Conjointement avec l'infirmier chef de département, les médecins et les infirmiers (ères) chefs d'unités de soins et de services, le chef de département est également chargé

- ❖ Évaluer périodiquement la qualité des soins et services
- ❖ Évaluer les besoins de formation continue du personnel médical et infirmier :
- ❖ Assurer du respect des règles d'hygiène et d'asepsie dans les services :
- ❖ Élaborer les protocoles cliniques généraux à suivre au sein du département et les chemins thérapeutiques, lorsqu'il s'agit de département ou de service clinique

### **• Attributions du chef du service médical**

Chaque service médical est placé sous l'autorité d'un médecin chef de service dans la discipline ou spécialité concernée, assisté d'un infirmier chef

Le chef de service médical est chargé d'organiser le fonctionnement de celui-ci dans le respect de la responsabilité médicale de chaque praticien. Il est notamment chargé de :

- ❖ Assurer de la présence des ressources humaines dans le service et prévoir les listes de garde
- ❖ Veiller au respect des règles d'éthique, de déontologie et de l'application des règles professionnelles
- ❖ Assurer l'encadrement des étudiants et stagiaires
- ❖ Évaluer périodiquement la qualité des soins et services
- ❖ Assurer du respect des règles d'hygiène et d'asepsie dans les services

### **Attributions des infirmiers chefs d'unités de soins et de services :**

Les infirmiers chefs des unités de soins et de services sont chargés d'organiser et de superviser le travail des infirmiers, des techniciens, du personnel de soutien au sein des départements ou des services

- ❖ Ils évaluent les besoins des patients et s'assurent que les soins et les prestations requises sont dispensées conformément aux prescriptions médicales
- ❖ Ils veillent sur la qualité des soins infirmiers dans le respect des procédures et des règles professionnelles, d'éthique et de déontologie
- ❖ Ils assurent l'encadrement des stagiaires, des infirmiers et des techniciens de santé stagiaires

### **Dispositions propres au service de la pharmacie hospitalière et au SAA :**

#### **Rattachement :**

La **pharmacie hospitalière** et le **service d'accueil et d'admission** sont deux services **médico-techniques**, placés sous **l'autorité** directe du **directeur de l'hôpital**

#### **Pharmacie hospitalière :**

La pharmacie hospitalière a pour mission d'assurer, dans le respect des règles qui régissent le fonctionnement de l'hôpital, la préparation, le contrôle, la détention, la distribution et la dispensation des médicaments et des dispositifs médicaux et de veiller à la préservation de leur qualité

La pharmacie hospitalière est placée **sous la responsabilité d'un pharmacien**

Le pharmacien responsable de la pharmacie hospitalière est chargé de la gestion de la pharmacie

Il assure notamment les fonctions suivantes :

- ❖ Mener ou participer à toute action d'information sur les médicaments et les dispositifs médicaux, de promotion et d'évaluation de leur bon usage
- ❖ Concourir à la pharmacovigilance et à la matériovigilance - Fournir l'information sur les dernières mises à jour de la nomenclature des médicaments et des dispositifs médicaux, ainsi que sur l'évolution de leurs prix
- ❖ Arrêter à partir de la nomenclature nationale et avec l'étroite collaboration du conseil des médecins, des médecins dentistes et des pharmaciens (CMDP), la liste des médicaments et des dispositifs médicaux nécessaires au fonctionnement de l'hôpital ou du centre hospitalier de rattachement pour donner suite aux commandes émanant des services, selon les procédures en vigueur
- ❖ Superviser le processus de réception des médicaments et des dispositifs médicaux
- ❖ Assurer la gestion des stocks des médicaments et des dispositifs médicaux en évitant le gaspillage, les stocks morts et les péremptions des produits
- ❖ Contribuer, à travers un système d'information au suivi de la traçabilité des médicaments et des dispositifs médicaux depuis la date de réception jusqu'à leur dispensation aux patients
- ❖ Veiller à la mise à jour du registre des stupéfiants selon la réglementation en vigueur
- ❖ Assurer un contrôle rigoureux du bon usage des médicaments et des dispositifs médicaux
- ❖ Participer à la surveillance des infections nosocomiales par le suivi de l'évolution de la consommation des médicaments notamment, les produits anti-infectieux
- ❖ Participer aux activités d'hygiène hospitalière
- ❖ Encadrer le personnel impliqué dans la gestion et l'utilisation des médicaments, des dispositifs médicaux et des produits d'hygiène ainsi que le personnel chargé de la stérilisation

Il est également chargé :

- ❖ Assurer la dispensation nominative sur ordonnance médicale des médicaments onéreux et des médicaments des affections de longue durée
- ❖ Assurer la disponibilité des médicaments et des dispositifs médicaux vitaux au niveau des services des urgences

## Service d'accueil et d'admission :

Le service d'accueil et d'admission est chargé des activités suivantes :

- ❖ Gérer l'accueil et l'orientation des patients
- ❖ Organiser les admissions et les sorties des malades ainsi que la gestion des rendez-vous
- ❖ Gérer les effectifs des patients et leurs mouvements à l'intérieur de l'hôpital
- ❖ Enregistrer les actes médicaux légaux et assurer la gestion de la morgue hospitalière
- ❖ Etablir les statistiques et gérer l'information hospitalière
- ❖ Etablir la facturation des prestations et services rendus par l'hôpital sur la base de la classification des maladies, des nomenclatures des actes et des tarifs en vigueur
- ❖ Organiser la communication interne et externe de l'hôpital
- ❖ Assurer l'assistance sociale aux patients
- ❖ Organiser et gérer les archives médicales et les dossiers des patients de l'établissement

Le service d'accueil et d'admission peut être **organisé en deux ou plusieurs** sections en fonction du volume des activités.

Il est **géré par un médecin**

### **V. Admission à l'hôpital**

L'utilisation des prestations et de services hospitaliers peut avoir lieu suivant l'un des modes suivants :

- ❖ **L'hospitalisation** y compris l'hôpital de jour, soit en **admission ordinaire**, soit en **urgence**
- ❖ Les prestations et services de diagnostic rendus à titre externe
- ❖ Les consultations spécialisées rendues à titre externe
- ❖ Les consultations et soins d'urgence
- ❖ Les prestations de rééducation et de réadaptation fonctionnelle.

## Conditions d'admission ordinaire :

On entend par admission ordinaire, **toute hospitalisation complète ou de jour**, programmée en **dehors des urgences**

Les modalités d'admission ordinaire s'effectuent au niveau du **service d'accueil et d'admission**

Tout refus d'admission doit être motivé par écrit

Aucune admission ordinaire en hospitalisation ne peut avoir lieu en l'absence d'une décision médicale prise par un médecin en fonction à l'hôpital

Le médecin hospitalier décide de l'admission sur la base de l'examen du patient ou de son dossier médical en cas de référence.

Lorsque le médecin décide l'hospitalisation, il doit :

Délivrer au patient une ordonnance médicale d'admission portant notamment **les indications suivantes** : l'identité du patient et motif d'hospitalisation, le département ou le service et la date de l'ordonnance

Établir une **demande d'accord** de prise en charge **PEC** pour les patients qui disposent d'une assurance maladie

L'ordonnance médicale d'admission et la demande d'accord doivent porter de façon lisible le **nom et la signature** du médecin ayant décidé l'hospitalisation

L'admission ordinaire **ne peut se faire** que pendant **les heures et les jours ouvrables** de la semaine

## Billet d'entrée :

**Aucun** patient peut être **hospitalisé** dans le cadre de **l'admission ordinaire** sans l'établissement d'un **billet d'entrée** par le **service d'accueil et d'admission**

Tout **manquement** à cette **règle** est passible de **sanctions disciplinaires**

Le **médecin chef** et **l'infirmier chef** du département ou du service sont chargés de veiller au **respect** de cette disposition et, le cas échéant, d'en informer immédiatement **le directeur** de l'établissement.

En cas **d'indisponibilité de lits**, l'hospitalisation peut être **programmée avec un rendez-vous** après avis du médecin ayant décidé l'hospitalisation. En aucun cas, l'hospitalisation ne peut être différée **si l'état de santé** du patient risque de **s'aggraver** et ou de **compromettre son pronostic vital**

### **Formalités d'admission ordinaire :**

Le patient ou son accompagnant se présente au service d'accueil et d'admission pour l'accomplissement des formalités administratives d'admission ordinaire, muni de **l'ordonnance** médicale d'admission, d'une **pièce d'identité** et des **documents exigés** par la réglementation en vigueur en fonction de son statut de **couverture médicale**

Si le patient **n'est pas assujéti à un régime de couverture médicale** et en l'absence d'affection justifiant son exonération conformément à la réglementation en vigueur, le patient ou en cas d'incapacité, sa famille, est informé de l'obligation du paiement direct de l'intégralité des frais d'hospitalisation suivant a **rémunération** en vigueur des services et prestations rendus par l'hôpital

### **Admission des accompagnants :**

A titre exceptionnel, si l'état de santé du patient l'exige et lorsque la disponibilité en lits le permet, le **directeur de l'hôpital** peut **autoriser l'admission d'un parent du patient** hospitalisé après avis du médecin traitant.

L'accompagnant est tenu à l'accomplissement des formalités administratives auprès du service d'accueil et d'admission

L'accompagnant **ne peut pas se prévaloir** de son maintien l'hôpital si les nécessités du service requièrent l'utilisation du lit qu'il occupe

### **Admission en urgence :**

Tout patient, **blessé ou parturiente** qui se présente en situation d'urgence doit être reçu, examiné et admis en hospitalisation, **le cas échéant**, si son état l'exige même en cas d'indisponibilité le lits. La procédure de facturation n'est entamée qu'après engagement de la prise en charge médicale

Si l'état du patient **n'est pas jugé médicalement urgent**, il est **référé** vers la structure de soins appropriée ou pris directement en charge en cas de possibilité, sous réserve de s'acquitter préalablement des frais inhérents à cette prise en charge.

Le patient admis aux urgences **reçoit les soins** requis. Si son état de santé **n'exige pas son hospitalisation**, il doit, préalablement à sa sortie, s'acquitter, auprès du service d'accueil et d'admission du paiement des frais des soins reçus

### **Hospitalisation d'urgence :**

L'hospitalisation est ordonnée par le **médecin des urgences** ou le **spécialiste de garde** ou **d'astreinte** dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'admission ordinaire

L'hospitalisation des parturientes peut être décidée par **la sage-femme** ou, le cas échéant **l'infirmière accoucheuse** sous **l'encadrement** du **médecin** ou du **gynécologue obstétricien** de garde qui établit à cet effet l'ordonnance médicale d'admission

### **Formalités d'admission en urgence :**

Les formalités d'admission en urgence ont lieu, dans les **mêmes conditions** que celles de l'admission **ordinaire**, à la suite de **l'administration des premiers soins** au patient reçu en urgence soit au chevet de ce dernier lorsque son état le permet, soit au **service d'accueil et d'admission** par sa famille, et dans tous les cas avant sa sortie de l'hôpital

Si le patient est **inconscient** lors de son admission en urgence **l'infirmier de garde** procède à **l'inventaire contradictoire des effets, objets ou sommes d'argent** en possession de l'intéressé et dresse un **procès-verbal** qu'il doit **signer conjointement** avec un **accompagnant du patient**, ou en cas d'inexistence d'accompagnant, par la personne l'ayant **transportée** aux urgences ou par deux témoins

Les **objets inventoriés** doivent être remis à **l'administration de l'hôpital** où ils seront conservés par l'agent responsable **des biens** des patients, désigné par le **directeur de l'établissement**. En tout cas, **ils ne peuvent être** remis par l'administration de l'hôpital qu'au patient **directement** lors de sa sortie ou à un membre de sa famille devant des témoins.

## Admission d'une personne décédée :

L'admission à l'hôpital d'une personne décédée est **interdite**

Cependant, en cas **d'inexistence de morgue municipale**, l'hôpital peut, à titre exceptionnel, recevoir le **corps** du défunt à la demande des **autorités compétentes**. Un **constat de décès** est établi portant la mention « **arrivé mort à l'hôpital** »

## Transfert d'un patient ou blessé admis en urgence :

Lorsque le médecin des urgences constate qu'un patient ou un blessé requiert des soins urgents relevant d'une discipline ou d'une technique n'existant pas à l'hôpital, il prodigue les premiers secours et ordonne le transfert du patient vers l'établissement approprié à son état de santé. Le directeur de l'hôpital ou son représentant prend toutes les dispositions nécessaires pour que le patient ou blessé soit dirigé dans des conditions sécurisées vers ledit établissement. Ce transfert doit se faire par le biais du centre de régulation médical quand il existe.

L'administration de l'hôpital doit informer la famille du patient de ce transfert

Le patient doit être informé préalablement à son transfert à un autre établissement. Sauf extrême urgence, le transfert ne peut être effectué, sans le consentement écrit du patient. Si ce dernier se trouve dans l'impossibilité de donner son accord écrit pour le transfert, l'administration de l'hôpital le mentionne sur son dossier, procède au transfert et en informe la famille ou les proches du patient dans les meilleurs délais

## Admission des patients mineurs :

Sauf cas d'urgence, l'admission d'un patient mineur a lieu dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'admission ordinaire à la demande du **père**, de la **mère**, du **représentant légal** ou, le cas échéant, du représentant de l'établissement qui héberge l'enfant

En tout état de cause, l'agent chargé du service d'accueil et l'admission doit vérifier l'identité de l'accompagnant et inscrire toutes les informations utiles (les noms, prénoms et numéro de la carte d'identité nationale) dans le formulaire d'admission



La mère d'un patient mineur, particulièrement, de **moins de 5 ans** ou son représentant légal de sexe féminin, peut être autorisée à rester auprès de l'enfant pendant le séjour de ce dernier l'hôpital. Toutefois, la **maman qui allaite doit obligatoirement être retenue auprès de son enfant**

Si le patient mineur n'est pas accompagné de l'une des personnes citées ci-dessus, l'hôpital lui prodigue les soins médicalement requis par son état de santé et informe le représentant légal lorsqu'il est identifiable ou, le cas échéant, les autorités de **police judiciaire**

### **Admission de mineurs dans les services pour adultes :**

En dehors des hôpitaux d'enfants, les mineurs de **moins de 12 ans** ne peuvent être admis dans les services pour adultes, sauf si leur cas relève d'une discipline ou d'une technique qui n'est pas pratiquée dans les unités de soins de pédiatrie ou de chirurgie pédiatrique

Dans ces conditions, le directeur de l'hôpital doit prendre toutes les mesures adéquates pour les séparer des adultes dans un lieu protégé permettant le bon déroulement du traitement

### **Scolarisation des mineurs hospitalisés :**

Lorsqu'au moins cinq ans enfants en âge de scolarisation sont hospitalisés pour une maladie de moyenne ou longue durée l'hôpital peut demander à **l'Académie régionale de l'éducation et de la formation** de mettre à sa disposition des enseignants en vue de leur dispenser l'enseignement adapté à leur niveau

Les enseignants doivent être tenus informés des problèmes de scolarisation des enfants provisoirement éloignés du milieu scolaire normal

Ils sont également informés de l'obligation du respect des prescriptions du présent règlement et des consignes médicales à prendre en considération

Durant leur période de service à l'hôpital, les enseignants ont droit au bénéfice des mesures de protection juridique et de protection contre les risques

Lorsqu'un enseignant manque à ses obligations professionnelles d'enseignement, ou qu'il agisse de façon gênant soit le déroulement du traitement, soit le fonctionnement du service, le médecin chef du département ou du service établit à ce sujet un rapport motivé, qu'il adresse au directeur de l'hôpital

Le directeur de l'hôpital doit demander des explications écrites à l'enseignant. Il peut également diligenter une enquête et adresser un rappel à l'ordre à l'enseignant, en cas de véracité des faits qui lui sont reprochés

Le directeur peut, en outre et s'il le juge nécessaire, transmettre à l'académie régionale de l'éducation et de la formation, sous couvert du délégué du ministère de la santé à la préfecture ou la province concernée, l'original du dossier disciplinaire assorti de son avis

Le directeur doit conserver une copie du dossier disciplinaire

### **Admission des patients malades mentaux :**

Les malades mentaux peuvent être soit hospitalisés à leur demande ou à la demande de toute autre personne publique ou privée, soit mis en observation

Lorsque l'hospitalisation est demandée par une personne autre que le malade concerné, elle doit être faite par **écrit** au directeur de l'hôpital.

Quel que soit le demandeur, l'hospitalisation ne peut être décidée qu'au vu d'un certificat délivré par un médecin psychiatre justifiant cette nécessité

Le certificat ne peut être délivré par un médecin parent ou allié du malade ou par la personne qui demande l'hospitalisation ou la mise en observation d'office d'un malade mental ne peut intervenir que :

- ❖ Par décision du gouverneur de la préfecture ou la province concernée sur avis conforme du médecin traitant lorsque la sortie du malade constituerait un danger pour sa vie, pour ses proches ou pour l'ordre public
- ❖ Ou sur ordonnance du juge

### **Admission des détenus :**

Lorsque le médecin de l'établissement pénitentiaire estime que les soins nécessaires ne peuvent être dispensés sur place ou s'il s'agit d'une affection épidémique, les détenus malades doivent être admis à l'hôpital le plus proche sur demande écrite du médecin de l'établissement pénitentiaire

Avant son admission, le détenu doit être examiné, sous la responsabilité du médecin chef de département ou du service qui s'assure de la nécessité de le garder à l'hôpital

Celui-ci peut à tout moment ordonner le renvoi du malade à l'établissement pénitentiaire s'il constate que le détenu peut recevoir les soins médicalement requis au sein dudit établissement

En tout état de cause, l'hospitalisation ne peut avoir lieu que sur ordonnance médicale d'admission et suivant les formalités administratives

En cas d'urgence, il peut être procédé à l'hospitalisation du détenu en vue des premiers soins urgents en attendant la demande écrite. Le directeur de l'hôpital est informé dans tous les cas

Si le médecin traitant de l'hôpital estime que le patient détenu doit recevoir des prestations de diagnostic ou de traitement dans un autre hôpital approprié, il en informe le directeur de l'hôpital qui assure le transfert du patient sous la responsabilité et la surveillance de l'administration pénitentiaire.

Les détenus sont admis, chaque fois que cela est possible, soit dans des chambres spécialement aménagées à cet effet à l'hôpital, lorsqu'elles existent, soit dans les lits où il est possible d'assurer la surveillance du détenu sans entraver le fonctionnement régulier du service hospitalier ni gêner les autres patients,

En tout état de cause, la responsabilité de la surveillance des détenus incombe exclusivement à l'établissement pénitentiaire

Les interrogatoires des patients par des autorités extérieures 'hôpital ne peuvent avoir lieu que sur autorisation expresse du directeur de l'hôpital après avis du médecin traitant,

### **Admission des patients appartenant au corps des Forces Armées Royales :**

En dehors des cas d'urgence, les patients militaires sont admis à l'hôpital dans les mêmes conditions que les civils, soit à leur demande, soit à la demande de l'autorité militaire

En cas d'admission en urgence d'un militaire, le directeur de l'hôpital informe l'autorité militaire ou, à défaut, la gendarmerie royale.

En cas d'hospitalisation et dès que l'état de santé du patient hospitalisé le permet, celui-ci peut être évacué vers l'hôpital militaire approprié s'il en manifeste le désir ou si l'autorité militaire le demande

### **Admission des patients atteints de maladies transmissibles :**

Lorsqu'il est confirmé que le patient hospitalisé est atteint d'une maladie transmissible à déclaration obligatoire, le directeur de l'hôpital est tenu d'en informer le délégué du ministère de la santé à la préfecture ou la province concernée et de remplir toutes les formalités prescrites pour la déclaration obligatoire et les mesures prophylactiques à prendre et l'isolement immédiat dudit patient le cas échéant

L'hospitalisation d'une personne atteinte de ce type de maladie ne peut être différée quelle qu'en soit la raison. Elle doit être prononcée même en cas d'indisponibilité de lits

En cas de danger grave pour la santé publique, le directeur de l'hôpital informe le délégué du ministère de la santé à la préfecture ou la province qui prend toutes les mesures nécessaires en concertation avec les autorités locales

### **Admission des victimes d'accidents de travail ou de maladies professionnelles :**

L'admission des personnes victimes d'accidents de travail ou de maladies professionnelles a lieu dans les mêmes conditions et formalités ordinaires ou en urgence

Ils sont soignés, contrôlés et le cas échéant, appareillés conformément à la législation en vigueur en la matière

Les certificats médicaux leur sont délivrés en vertu de cette même législation. Ils sont établis par les médecins désignés à cet effet au niveau de l'unité chargée des accidents de travail

## **Admission des ressortissants étrangers :**

Les patients ou blessés non marocains sont admis, quels que soient leurs statuts, dans les mêmes conditions que les nationaux

Les modalités de facturation des prestations qui leur sont prodiguées doivent s'effectuer dans les mêmes conditions sauf en cas d'existence de convention de soins entre le Maroc et le Pays dont le patient est ressortissant

## **Consentement préalable aux soins :**

Sauf disposition légale spécifique et quel que soit le mode d'admission, un formulaire de consentement doit être signé par le patient ou son représentant légal pour les actes de diagnostic de soins ou de services qui lui seront prodigués au cours de son séjour à l'hôpital

S'il apparaît, lors de l'admission d'un patient mineur, que le consentement de son représentant légal, ne peut être obtenu à brève échéance, l'autorisation de pratiquer l'opération ou les opérations nécessaire(s), et les actes qui lui sont liés peut-être exigée dudit représentant légal au cours de l'hospitalisation

Dans le cas où le représentant légal peut donner une autorisation écrite à bref délai, elle lui est demandée aussitôt que l'intervention chirurgicale s'avère nécessaire

L'intervention prévue doit se pratiquer dans les conditions :

- ❖ L'urgence doit être constatée et l'intervention décidée par le médecin hospitalier concerné
- ❖ L'intervention doit être pratiquée par ce médecin ou sous sa supervision
- ❖ La décision d'opérer doit être portée à la connaissance du représentant légal ou de la personne ayant la charge de l'enfant

Elle fait l'objet d'un protocole contresigné par le médecin hospitalier et le directeur de l'hôpital et conservé dans le dossier d'hospitalisation du patient mineur

En cas de refus d'autorisation ou s'il s'avère impossible de recueillir le consentement, il ne peut être procédé à l'intervention qu'en cas d'urgence et seulement lorsque la vie de l'enfant est en péril ou lorsque son intégrité corporelle est menacée

Un procès-verbal de refus doit être dressé et signé par le représentant de l'administration et la personne ayant la responsabilité de l'enfant ou, à défaut, par deux témoins

## **VI. Le dossier d'hospitalisation**

Le dossier d'hospitalisation est **constitué pour chaque patient hospitalisé**

Le dossier d'hospitalisation **est la propriété de l'hôpital** qui en assure la conservation

Dès **la sortie du patient**, le dossier d'hospitalisation est transmis au service en charge des archives médicales de l'hôpital. Dans certains cas, le directeur de l'hôpital peut accorder en fonction des besoins de chaque département ou service, un délai supplémentaire de conservation du dossier dans les unités de soins avant son transfert aux archives médicales de l'hôpital

Sous la responsabilité du chef du département ou de service et du chef de l'unité de soins ou des services concernés, les praticiens et les infirmiers sont tenus chacun en ce qui le concerne, de remplir au quotidien, exhaustivement et lisiblement le dossier d'hospitalisation

Le personnel de l'hôpital doit prendre toutes les mesures adéquates pour sauvegarder le caractère confidentiel des renseignements contenus dans le dossier d'hospitalisation

Le dossier d'hospitalisation **peut être consulté par le patient ou son représentant légal**, ses ayants droit en cas de décès par l'intermédiaire de son médecin traitant externe à l'hôpital

Le patient ou son médecin représentant disposent du droit de consultation du dossier d'hospitalisation sur place, en présence du médecin hospitalier traitant

Le patient peut se faire communiquer, par l'intermédiaire de son médecin hospitalier traitant, une copie du dossier hospitalier et/ou un compte rendu détaillé de sa prise en charge médicale, sur la base d'une demande présentée par le patient au directeur de l'hôpital

En cas de **transfert du patient** vers un autre établissement hospitalier, **le compte rendu détaillé**, ainsi que **la copie du dossier** dont le contenu doit être listé sur un bordereau de transmission sont communiqués à l'établissement d'accueil, qui en accuse réception en signant une copie du bordereau

Le dossier d'hospitalisation peut être communiqué dans un but scientifique à tout membre du corps médical en vue d'une consultation sur place, sur autorisation du directeur de l'hôpital

### **Procédure du transfert d'un patient vers un autre hôpital :**

En cas d'absence d'unités pouvant assurer adéquatement la prise en charge médicale d'un patient, et que l'état de santé de celui-ci l'exige, le médecin traitant établit une ordonnance médicale de transfert vers la structure hospitalière publique la plus appropriée ou, en cas de nécessité vers un des centres hospitaliers créés en vertu de la loi n° 37-80

Le directeur de l'hôpital prend les mesures administratives nécessaires au transfert du patient dans les délais raisonnables et en informe sa famille

Le transfert vers une clinique ou établissement assimilé ne peut avoir lieu qu'à la demande écrite du patient ou de sa famille ou en cas d'existence de convention de soins entre l'hôpital public et le lieu d'hospitalisation privé concerné

L'infirmier chef de l'unité de soins concerné doit prendre rendez-vous avec la structure d'accueil et organiser, suffisamment à temps, le transport du patient

Le patient doit être informé du jour du rendez-vous en vue de l'examen ou du traitement préconisé

Le jour du rendez-vous, le patient est transporté par les moyens de l'hôpital où il séjourne ou par le biais d'une ambulance privée, aux frais du patient. Dans les deux cas, le patient doit être assisté par un personnel soignant de l'hôpital. Le patient doit être accompagné d'une fiche de liaison, de son dossier hospitalier ou à défaut d'un résumé clinique comportant tous les renseignements utiles pour la consultation ou l'examen.

Lorsque les unités de diagnostic et de traitement implantées dans une formation hospitalière sont destinées à l'usage commun d'un ensemble "hôpitaux relevant ou pas d'un centre hospitalier elles doivent être utilisées, sauf cas d'urgence, sur la base d'un protocole établi par le directeur de l'hôpital lieu d'implantation desdites unités, en concertation avec les directeurs des hôpitaux concernés.

## **Information du patient, de la famille et de la police judiciaire locale :**

Lorsqu'un patient mineur, incapable ou en état d'inconscience est hospitalisé en urgence, toutes les mesures utiles doivent être prises le plus rapidement par les services compétents de l'hôpital pour identifier et prévenir, en cas de possibilité, sa famille ou, le cas échéant, informer l'autorité de la police judiciaire locale

Les patients hospitalisés doivent être informés du nom et de la qualité des personnes appelées à contribuer au diagnostic de leur état de santé, à leur prodiguer des soins ou à veiller sur l'ordre et l'hygiène

Les patients sont informés préalablement de la nature des risques et des conséquences que les actes médicaux et chirurgicaux peuvent entraîner.

Ces informations sont communiquées par les médecins traitants s'ils le jugent utile, à la famille du patient sous réserve de l'accord préalable de celui-ci s'il est capable de l'exprimer

Le personnel infirmier participe à cette information dans son domaine de compétence et s'abstient notamment de donner des informations sur le diagnostic, le pronostic ainsi que l'évolution de l'état de santé

Lors de son admission ordinaire à l'hôpital, le patient est informé des dispositions du présent règlement intérieur et de l'obligation de s'y conformer. Une copie du présent règlement ou des dispositions le concernant peut lui être communiquée à sa demande

Le patient est également informé que l'hôpital ne peut être tenu pour responsable de la perte ou du vol des objets qu'il conserve sur lui au cours de son séjour à l'hôpital

En outre, le personnel hospitalier doit en toute circonstance donner les informations d'usage permettant à chacun des usagers de contribuer au bon fonctionnement, à la sécurité et à l'hygiène de l'hôpital



## **VII. Les motifs de sortie :**

Le patient hospitalisé peut normalement quitter l'hôpital, soit sur indication du médecin traitant ou lorsque son transfert vers un autre hôpital est décidé pour des raisons médicalement motivées, soit à sa demande

### **Sortie pour fin de traitement :**

Lorsque le médecin traitant du patient hospitalisé estime que l'état de santé de celui-ci ne nécessite plus son maintien à l'hôpital, il prononce la sortie ordinaire du patient

Lors de la visite médicale journalière, le médecin traitant désigne les patients sortants suffisamment à l'avance pour permettre l'information de la famille et la préparation des documents nécessaires à la sortie

La sortie ordinaire des patients a lieu tous les jours ouvrables de préférence avant midi. Elle ne peut avoir lieu après **18h** sauf lorsqu'il s'agit d'un transfert urgent

L'administration de l'hôpital prend toutes les mesures pour informer la famille du patient préalablement à sa sortie de l'hôpital

La sortie des patients mineurs ne peut être effectuée qu'entre les mains du représentant légal ou de la personne qui a accompagné l'enfant lors de son admission ou de toute autre personne autorisée par les parents à cet effet, à la condition d'apporter les justifications nécessaires

La sortie des malades mentaux hospitalisés d'office doit être effectuée en concertation avec les autorités avant ordonné la mise en observation ou l'hospitalisation d'office

En cas de refus du patient de quitter l'hôpital, le cas est porté à la connaissance du directeur de l'hôpital qui prend les mesures nécessaires pour concrétiser la sortie, y compris le recours aux services de police

### **Sortie pour cause d'aggravation de l'état du patient :**

Lorsque les médecins d'une unité de soins constatent que l'état d'un patient est particulièrement grave, qu'il est agonisant ou au-dessus de toute ressource thérapeutique, ils peuvent, après accord du médecin chef du département, consentir à son transfert à domicile, si lui-même ou sa famille en exprime la volonté par écrit

Si le transfert à domicile n'est pas demandé et si les moyens de l'hôpital le permettent, le patient peut être transporté discrètement dans une chambre individuelle de l'unité de soins

Ses proches peuvent être admis à rester auprès de lui pour l'assister dans ses derniers moments

### **Sortie volontaire du patient avec accord médical :**

En dehors du cas particulier des patients mineurs, de certains patients hospitalisés d'office et des incapables, les patients peuvent, à leur demande, quitter l'hôpital à la condition d'effectuer au préalable les formalités administratives de sortie

Toutefois, si le chef de département ou de service estime que cette sortie est prématurée et qu'elle comporte un danger pour la santé du patient, il doit exiger de ce dernier la signature d'une attestation certifiant qu'après avoir pris connaissance des dangers que représente cette sortie, il persiste dans sa demande. En cas de refus du patient, un procès-verbal est établi et signé en présence de deux témoins

### **Sortie contre avis médical :**

Lorsque le patient refuse les examens, traitements, interventions et soins qui lui sont proposés, un procès-verbal contradictoire est dressé et signé conjointement par le représentant de l'administration et le patient. En cas de refus de ce dernier, il est fait appel à des témoins.

La sortie est alors prononcée par le chef de département ou service concerné, sur rapport du médecin traitant, sauf si l'état du patient nécessite des soins urgents. En outre, le bulletin de sortie qui est délivré dans ce cas au patient doit porter la mention « sortie contre avis médical »

## **Sortie par mesure disciplinaire :**

En cas de manquement grave aux prescriptions du présent règlement ou lorsqu'un patient dûment averti cause des troubles perturbant le fonctionnement du ou des services de l'établissement le directeur de l'hôpital peut, sur rapport du médecin traitant prononcer sa sortie pour des raisons disciplinaires

Toutefois cette sortie ne peut avoir lieu si l'état de santé du patient ne le permet pas. Dans ce cas, l'administration de l'hôpital doit informer, par écrit et dans les meilleurs délais, les autorités de police judiciaire pour prévenir d'éventuelles réactions dangereuses du patient vis-à-vis du personnel, des autres patients hospitalisés ou vis à vis des biens de l'hôpital

## **Les formalités de la sortie**

### **1. Formalités médicales**

Dès que la sortie est décidée pour quelques causes que ce soit, le médecin traitant doit indiquer si le patient nécessite un suivi au moyen de consultations externes jusqu'à sa guérison ou jusqu'à la consolidation de ses blessures. Il doit établir les certificats médicaux utiles au patient pour la justification de ses droits. Il établit les ordonnances visant la continuité des soins en précisant, le cas échéant, la date de la prochaine consultation à titre externe

L'infirmier chef de l'unité de soins donne au patient toutes les informations et les conseils nécessaires à la continuation du traitement et lui remet les documents de sortie

La sortie de tout patient est enregistrée sur une fiche spéciale versée à son dossier d'hospitalisation

### **2. Formalités administratives :**

Les patients sortants ou leurs parents doivent procéder aux formalités de sortie auprès du service d'accueil et d'admission

Les formalités de sortie comportent les étapes suivantes :

- ❖ Enregistrement des nom et prénom du patient sur le registre des sortants
- ❖ Facturation et règlement des frais d'hospitalisation ou signature des documents de prise charge

- ❖ Restitution des effets personnels et toutes valeurs confiées à l'hôpital sur présentation de l'attestation de dépôt délivrée lors de l'admission
- ❖ Délivrance du billet de sortie

### **Sortie d'un patient à l'insu du personnel hospitalier :**

Au cas où un patient quitte l'hôpital à l'insu du personnel médical le chef du département ou du service ou, à défaut, le médecin de garde doit établir un procès-verbal constatant la disparition du patient, relater tous les renseignements sur le patient et préciser la date de sortie ou de disparition qu'il transmet au directeur de l'hôpital

Le directeur de l'hôpital prend, en outre, toutes les dispositions nécessaires pour informer immédiatement les autorités de police judiciaire et la famille du patient et en informe le délégué du Ministère de la Santé à la préfecture ou province concernée

Le patient doit être porté sortant aux registres des patients hospitalisés

### **Permission de sortie :**

Les patients peuvent, compte tenu de la durée de leur séjour, et lorsque leur état de santé le permet, bénéficier de permissions de la permission de sortie est établie par l'infirmier chef de l'unité de soins sur le formulaire destiné à cet usage

La permission doit être signée par le médecin traitant

Les permissions de sortie sont enregistrées dans un registre spécifique au niveau du service d'accueil et d'admission mentionnant le nom du patient, le médecin ayant autorisé la sortie ainsi que la date et la durée de celle-ci.

Le formulaire est versé au dossier d'hospitalisation.

Si à l'issue du délai de permission le patient ne rentre pas l'administration la porte sortante.

Il ne pourra être réhospitalisé que lorsque la disponibilité en lits le permettra